Bilan des Réunions de Concertation Pluridisciplinaire (RCP) au Centre Hospitalier Universitaire Sourô Sanou : constats, difficultés et perspectives

Nom du présentateur : Damien KONKOBO

Auteurs et coauteurs : MCA Ollo Roland SOME, Pr Adolphe Der SOME, Dr Alex BOENA

Affiliations : INSSA / CHUSS

Plan

- Introduction
- Objectif
- Matériel et méthode(s)
- Résultats
- Conclusion

Introduction

- Les RCP Pilier PEC Moderne du cancer

- Approche:
  - Collégiale
  - Individualisée
  - Conforme (standards thérapeutiques)

- Les RCP améliorent la qualité PEC oncologie.

Introduction

- ARRETE N 2025- 353 MS/CAB DU 09/06/2025

Article 2 : La « RCP-Oncologie » est un espace d'échange entre professionnels de santé impliqués dans la prise en charge des cancers. Le but est d'offrir à chaque patient atteint de cancer la meilleure démarche diagnostique, les meilleurs soins, le meilleur suivi et la meilleure survie.

Les décisions s'appuient sur les Standards, les Options et les Recommandations (SOR) en oncologie en vigueur.

Objectifs

- RCP → **INNOVATION** organisationnelle (systèmes de santé PED).

Au Centre (CHUSS) de Bobo-Dioulasso

✓ Mises en place des RCP

✓ 1ere le 27 Janvier 2025

Cette communication aborde **3 OBJECTIFS:**

- **Dresser un bilan de cette expérience initiale**
- **Analyser les difficultés rencontrées**
- **Proposer des perspectives d'amélioration.**

Matériel et méthode(s)

- **ETUDE DESCRIPTIVE** et **ÉVALUATIVE**

- Période de **6 MOIS** (Janvier-Juin 2025)

- Données issues : 10 RCP / 35 DOSSIERS

  - Comptes rendus (registre),
  - Observation directe,
  - Echanges avec les participants

Matériel et méthode(s)

VARIABLES ETUDIEES

- Fréquence des réunions
- Pathologies discutées
- Composition des spécialistes
- Schémas thérapeutiques décidés
- Obstacles à leur application

Résultats

- 10 RCP en 6 mois soit 1RCP / 2,4 Sem
- 3,5 dossiers / RCP (35 dossiers)
- Pathologies discutées incluaient :

  - ✓ cancers gynéco-mammaires,
  - ✓ cancers digestifs et hépato-pancréatico-biliaires,
  - ✓ cancers des tissus mous, osseuses et cutanés,
  - ✓ cancers urologiques
  - ✓ ORL.

Résultats

Chaque RCP

- ❑ Participation régulière:
- ✓ Un oncologue chirurgien
- ✓ Un oncologue médical
- ✓ Un hépato-gastro-entérologue
- ✓ Un anatomopathologiste
- ❑ Participation irrégulière:

Un gynécologue, un chirurgien général, un radiologue, un ORL, un orthopédiste.

Résultats

Décisions thérapeutiques

- ❑ TTT spécifiques physiques:
- ✓ Chirurgie
- ✓ Radiothérapie
- ❑ TTT spécifiques médicamenteux:
- ✓ Chimiothérapie
- ✓ Hormonothérapie
- ✓ Thérapies ciblées
- ❑ Soins palliatifs purs

Résultats

Contraintes et obstacles

- Difficultés organisationnelles :

✓ Indisponibilité de certains spécialistes

✓ Irrégularité dans la tenue des réunions.

✓ Absence de coordination centralisée (pas de secrétariat de RCP dédié).

✓ Dossiers médicaux souvent incomplets ou non actualisés.

Résultats

Contraintes et obstacles

- Contraintes de ressources :

✓ Plateau technique limité (radiothérapie)

✓ Retards diagnostic (imagerie, anatomopathologie).

✓ Indisponibilité ou coût élevé de certains anticancéreux.

Résultats

Contraintes et obstacles

- Barrières à l'application des décisions :

- ✓ Décalage entre les recommandations théoriques et les possibilités concrètes.

- ✓ Problèmes de suivi post-RCP : absence de système structuré de mise en œuvre et d'évaluation

disponibilité des spécialistes •

Résultats

Perspectives

- Nommer un coordinateur de RCP.
- Création d'un secrétariat de RCP
- Mise en place d'un registre des décisions et d'un système de suivi
- Renforcement du plateau technique local
- **Plaidoyer institutionnel** pour la reconnaissance (fait) et le financement pérenne des RCP

Conclusion

- RCP = avancée majeure en oncologie.
- Favorisent la décision collégiale et harmonisée.
- Leur efficacité dépend des ressources disponibles.
- Expérience encourageante malgré les difficultés.
- Potentiel d’impact significatif.
- Besoin d’un appui institutionnel pour pérenniser le dispositif.

Merci pour votre attention